



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2023-119991836- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2023-119991836- -APN-DR#CNDC y el Expediente de tramitación conjunta N° EX-2024-52636601- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que las operaciones que analiza la presente medida involucran a dos actores de relevancia en el sector salud argentino, y se trata de una secuencia de transacciones que, inicialmente, resultó en la toma de control conjunto de estos actores sobre una empresa de medicina prepaga con activos sanatoriales significativos y que, posteriormente, derivó en una reorganización que implicó la separación y reparto de los activos de medicina prepaga y centros sanatoriales entre las partes adquirentes.

Que la operación de concentración económica que tramitó como Concentración 1938 fue perfeccionada el día 2 de octubre de 2023 y notificada el 9 de octubre de 2023, y consiste en la adquisición del control conjunto sobre la firma MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA y sus controladas SANATORIO LAS LOMAS S.A. y MET CÓRDOBA S.A. por parte de las firmas PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A. y SWISS MEDICAL S.A.

Que previo a la transacción, la estructura accionaria de la firma MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA estaba conformada por TRES (3) grupos de accionistas con participaciones accionarias aproximadas de un tercio cada uno: SWISS MEDICAL S.A., PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A. y «Grupo Pavlovsky» (35,54%).

Que la precitada operación, supuso la salida del «Grupo Pavlovsky» de la firma MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA tras un acuerdo verbal entre las firmas SWISS MEDICAL S.A. y PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A. para desvincular personal clave en las decisiones de directorio de MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA.

Que posteriormente, se celebró un contrato de compraventa de acciones mediante el cual subsidiarias del «Grupo Pavlovsky» vendieron su participación accionaria en MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA a los otros dos grupos accionistas.

Que la operación de concentración económica que tramitó como Concentración 1975 fue perfeccionada con fecha 14 de mayo de 2024 y notificada el 21 de mayo de 2024— consiste en una reorganización societaria y de las unidades de negocio de las firmas MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA, por la cual: (i) PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A. adquirió el control exclusivo sobre MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA, la cual mantiene el co-control de su subsidiaria MET CÓRDOBA S.A.; y (ii) SWISS MEDICAL S.A. adquirió el control exclusivo sobre SANATORIO LAS LOMAS S.A.

Que la concentración económica 1975 se instrumentó mediante un Convenio Marco de Reorganización Societaria.

Que las operaciones notificadas constituyen concentraciones económicas en los términos del Artículo 7°, incisos c) y d), de la Ley N° 27.442, respectivamente.

Que la obligación de efectuar las notificaciones obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 —monto que, al momento del cierre de la concentración económica 1938, equivalía a PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES (\$ 16.255.000.000) y de la concentración económica 1975, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (\$ 50.619.000.000)— y las transacciones no encuadran en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que el día 9 de octubre de 2023, las firmas SWISS MEDICAL S.A. y PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A. notificaron la concentración económica que tramitó como Concentración 1938 en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442.

Que con fecha 21 de mayo de 2024, las firmas SWISS MEDICAL S.A. y PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A. notificaron la concentración económica que tramitó como Concentración 1975 en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442.

Que el día 27 de mayo de 2024, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA considerando la conexidad entre las transacciones y la identidad de las partes intervinientes, dispuso la acumulación de la concentración económica 1975 a la concentración económica 1938.

Que se requirió información a terceros entre ellos: ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS (OSDE), GALENO ARGENTINA S.A., ASOCIACIÓN MUTUAL SANCOR, OMINT S.A. DE SERVICIOS, MEDIFE ASOCIACIÓN CIVIL, ACCORD SALUD (UPCN), SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES.

Que a excepción de los DOS (2) últimos requerimientos-que se dejan sin efecto en la presente medida, todos los pedidos restantes fueron oportunamente contestados.

Que con fecha 6 de enero de 2025, SWISS MEDICAL S.A. solicitó la dispensa de presentar la totalidad de los balances de las empresas afectadas.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró que la información aportada por la firma SWISS MEDICAL S.A resultó suficiente para la investigación y por lo tanto corresponde eximir a la empresa de aportar la documentación.

Que como se indicó, la Concentración Económica 1938 consiste en la toma del control conjunto sobre las firmas MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA y sus controladas SANATORIO LAS LOMAS S.A. y MET CÓRDOBA S.A. por parte de las firmas PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A. y de SWISS MEDICAL S.A., mientras que la Concentración Económica 1975 consiste en la toma de control exclusivo sobre las firmas SANATORIO LAS LOMAS S.A. por parte de SWISS MEDICAL S.A., y sobre MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA por parte de PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A.

Que, dado que el tiempo transcurrido entre ambas operaciones no fue suficiente para generar efectos económicos significativos en los mercados involucrados, cualquier efecto que pudiera haberse producido se habría disuelto a partir de la implementación de la concentración económica 1975.

Que el Grupo Swiss Medical» se encuentra activo en la oferta de servicios de medicina prepaga y en la prestación de servicios sanatoriales a través de clínicas y sanatorios localizados en distintos puntos del país, y por su parte, la firma PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A, controlada por miembros de la Familia DE ALL, se dedican, entre otras actividades, a la prestación de servicios sanatoriales mediante el SANATORIO OTAMENDI.

Que en relación a los posibles efectos horizontales que pudiera generar esta toma de control en el mercado de atención sanatorial, cabe destacar que los centros médicos operados por la firma MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA están orientados exclusivamente a la atención de afiliados propios, por lo que no existe solapamiento con los servicios ofrecidos por el SANATORIO OTAMENDI a terceros.

Que en el sistema de salud argentino existen tres subsistemas: la salud pública, la seguridad social, integrada por las obras sociales nacionales, provinciales y la de jubilados, y la medicina prepaga.

Que, de este último grupo, la mayoría derivan aportes vía planes corporativos o desregulación de obras sociales, mientras que el CUARENTA POR CIENTO (40%) restante adhieren de forma directa sin usar como intermediario a las obras sociales.

Que los actores del mercado habitualmente se refieren a las obras sociales y empresas de medicina prepaga como las “financiadoras”, dado que son éstos los actores que movilizan fondos a los distintos prestadores privados de la salud, aguas abajo.

Que, en el ámbito privado de la salud, hay tres actores que interactúan entre sí: pacientes, prestadores de servicios médicos y financiadoras de la salud.

Que el accionar de las obras sociales y empresas de medicina prepaga es regulado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD cuyo principal objetivo es fiscalizarlas para garantizar los derechos de los beneficiarios a las prestaciones de salud.

Que el servicio de medicina prepaga consiste en la cobertura de atención sanitaria, que incluye una amplia gama de prestaciones médicas, desde consultas y tratamientos hasta internaciones y cirugías.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ya analizó el mercado de medicina prepaga previamente y lo definió como “aquel en el que se comercializan planes de salud a cambio de pagos voluntarios de particulares o mediante convenios con obras sociales, empresas o asociaciones de personal jerárquico.”

Que, desde el punto de vista de la oferta, las empresas de medicina prepaga deben contratar prestadores de salud para satisfacer las necesidades de sus afiliados, o pueden también integrarse verticalmente en la atención directa de ciertos servicios.

Que la mayoría de las empresas de medicina prepaga como Swiss Medical, Medicus, Omint o Medifé, se encuentran integradas verticalmente en la prestación de servicios sanatoriales.

Que existen también prestadores asistenciales que ganaron prestigio y se integraron hacia adelante ofreciendo planes de salud propios, y algunos de estos son el Hospital Alemán, el Hospital Británico o el Hospital Italiano.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, indicó que desde el punto de vista de la demanda, mientras las obras sociales captan a sus afiliados a través de los aportes compulsivos, las empresas de medicina prepaga captan afiliados que no estén en relación de dependencia, o aquellos que sí lo están y eligen un plan superior.

Que, por ende, las empresas de medicina prepaga compiten por captar clientes según sus preferencias y para tal fin segmentan la oferta en planes.

Que algunas de las características que diferencian las distintas coberturas de salud son si los planes resultan ser abiertos o cerrados, el tipo y número de prestadores en cartilla, la cobertura geográfica en el país, si ofrecen o no cobertura en el exterior, el número de consultas máximas en ciertas especialidades, posibilidad de pedir reintegro en algunas especialidades, y la cobertura de tratamientos y/o cirugías odontológicos, oftalmológicos y estéticos.

Que en relación a las diferencias entre las empresas de medicina prepaga las partes notificantes informaron que en la actualidad las empresas de medicina prepaga grandes suelen ofrecer una amplia variedad de planes, que pueden variar entre CINCO (5) y NUEVE (9) opciones distintas, diseñadas para adaptarse a diferentes necesidades y niveles de cobertura, desde opciones básicas hasta planes premium, mientras que las empresas de medicina prepaga pequeñas suelen contar con un catálogo más acotado y una estructura menor, por lo que los planes que ofrecen no suelen ser más de TRES (3).

Que, desde el punto de vista geográfico, las grandes empresas de medicina prepaga ofrecen cobertura nacional, con acceso simultáneo a múltiples establecimientos de salud y servicios adicionales localizadas en todo el país, y con esta perspectiva las principales empresas de medicina prepaga desarrollan su estrategia comercial, ya que se ubican distribuidas en las grandes ciudades.

Que las empresas de medicina prepaga más pequeñas, como se señaló, suelen ofrecer planes con menor cantidad de prestadores o prestadores locales, o incluso un único prestador, motivo por el cuál, dada la naturaleza de su prestación, tienen un enfoque de coberturas locales, regionales o provinciales, y la red de profesionales es más reducida, concentrada en áreas más puntuales y específicas.

Que, dado los criterios de clasificación y segmentación utilizadas en el pasado por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y consideraciones realizadas por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD en sus informes técnicos, resulta pertinente que, a los fines del análisis de las presentes

operaciones, sean consideradas las grandes prestadoras de medicina privada con influencia nacional, comprendiendo a aquellas empresas de medicina prepaga con centros médicos propios y/o con más de CIEN MIL (100.000) afiliados.

Que el mercado de prestación de servicios sanatoriales en Argentina incluye la atención sanitaria en una variedad de instituciones, como clínicas, sanatorios y hospitales, que ofrecen servicios médicos y quirúrgicos a la población.

Que la prestación de servicios sanatoriales en centros de salud privados en Argentina incluye distintas etapas que van desde la admisión y diagnóstico inicial, el diagnóstico y planificación del tratamiento, la intervención y tratamiento, lo que puede incluir medicación, terapias, procedimientos no invasivos, intervenciones quirúrgicas, cuidados postoperatorios, y finalmente la rehabilitación y seguimiento.

Que la naturaleza de las prestaciones que ofrezca, una institución sanitaria puede ser monovalente y estar dedicada exclusivamente a una única área de la medicina, o puede ser polivalente y ofrecer servicios sanitarios relacionados a una amplia variedad de especialidades.

Que para que un sanatorio califique como de “alta complejidad” debe contar con una unidad de cuidados intensivos, quirófanos y centros de procedimientos aptos para todo tipo de cirugía, en particular cirugías complejas, incluida cardiocirugía y neurocirugía, tecnología avanzada para diagnósticos y tratamientos y equipos médicos especializados, diagnóstico e intervencionismo endovascular; diagnóstico endoscópico, y diagnóstico por imágenes que incluya tomografía y resonancia magnética.

Que una característica diferencial que también puede ser considerada desde el punto de vista de la demanda a la hora de elegir un centro de salud privado es el servicio de hotelería que puede tener un sanatorio.

Qué acuerdo a lo informado por las empresas de medicina prepaga involucradas, las relaciones comerciales que establecen con los prestadores de centros médicos sanatoriales son de larga duración, estableciendo contratos que son renovados y actualizados periódicamente en cuanto a los servicios alcanzados y costo, y en términos generales, las principales características acordadas son los planes atendidos y la cobertura de los mismos, servicios contratados, precio, plazo de pago, y la documentación a suministrar para que se reconozca el servicio brindado.

Que muchas de las empresas de medicina prepaga están integradas verticalmente en la prestación de servicios sanatoriales, lo que tendría ciertos beneficios desde el punto de vista de la calidad de atención y, de acuerdo a lo informado en el marco de la instrucción, podría dar lugar a diversas innovaciones como el acceso a plataformas integradas de consultas en línea, atención coordinada, entre otros.

Que, bajo este modelo comercial de mayor integración, en general la mayor cantidad de pacientes atendidos en cada uno de los centros corresponde a las empresas de medicina prepaga que gestiona la institución.

Que, en consecuencia, es destacable que el tipo de plan no supone ninguna prioridad o restricción con respecto al acceso a un sanatorio u hospital o calidad del servicio médico brindado, y todos los pacientes, independientemente del plan que tengan, reciben la misma atención médica de las prestaciones que tengan cobertura.

Que la diferenciación de los planes determina el tipo de prestación al que se accede —práctica o procedimiento específico— que se le brinda a un paciente en función al servicio que se tiene contratado, no teniendo incidencia

alguna respecto a la calidad o rapidez de la misma, ni realizando tratamiento preferente alguno por contar con cobertura de medicina prepaga del mismo grupo.

Que si bien en general ciertos centros médicos se caracterizan por atender planes superiores —dado el estándar de atención sanitaria que cuentan, así como el nivel del equipamiento y de sus instalaciones—, esta asociación no es lineal ni estática.

Que conforme al análisis realizado por la citada Comisión Nacional el servicio de hotelería es un servicio accesorio o complementario al tratamiento médico que buscan los pacientes, y si bien es un diferencial, lo determinante a la hora de evaluar el mercado desde el punto de vista de la demanda es el servicio estrictamente médico, y, por el contrario, la alta complejidad de la atención médica sí es un factor necesario para delimitar el mercado.

Que, considerando los efectos de las operaciones de adquisición notificadas, y en consonancia con los antecedentes de la propia COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, los servicios de prestación de servicios sanatoriales ofrecidos por centros médicos polivalentes de alta complejidad serán evaluados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

Que uno de los efectos que tiene la adquisición del SANATORIO LAS LOMAS S.A por parte de «Grupo Swiss Medical» es el solapamiento en la actividad de atención sanatorial, y el aumento de la concentración en este mercado se verifica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, conforme a la delimitación del mercado geográfica propuesta.

Que «Grupo Swiss Medical» gestiona sanatorios polivalentes en distintas partes del país, de los cuales CUATRO (4) se localizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 1 en zona norte del Gran Buenos Aires, mientras que el SANATORIO LAS LOMAS S.A, cuenta con CUATRO (4) centros, TRES (3) de ellos con camas de internación en la Provincia de BUENOS AIRES y una sede en Caballito donde funcionan consultorios externos.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró que el indicador más representativo de la capacidad operativa de los sanatorios es el número de camas de internación.

Que las partes notificantes en los informes técnicos aportados manifestaron la existencia de más de CINCO MIL (5.000) camas de internación de centros de salud privados polivalentes de alta complejidad en parte de la zona geográfica afectada.

Que la firma SWISS MEDICAL S.A. es el principal grupo proveedor de servicios sanatoriales, dado que lidera el mercado con el TRECE POR CIENTO (13%) de participación y la adquisición del SANATORIO LAS LOMAS, si bien aumenta la concentración, tendría un impacto poco significativo dado que representa el UNO COMA SEIS POR CIENTO (1.6%).

Que en términos de variación del HHI, si el aumento que se produce es menor a CIENTO CINCUENTA (150) puntos, y la participación conjunta de las empresas involucradas es menor al CINCUENTA POR CIENTO (50%), eso se tomará como un indicador de que la operación de concentración bajo análisis no despierta preocupaciones desde el punto de vista de la defensa de la competencia y en este caso, la variación HHI sería de CUARENTA Y UNO COMA OCHO (41,8) puntos, situación que confirma un escenario poco preocupante desde el punto de vista de la competencia.

Que, por lo tanto, la presente operación no genera preocupación en términos de reducción de la competencia.

Que, desde el punto de vista vertical, cabe analizar el refuerzo de la integración producto de la operatoria de la firma SWISS MEDICAL S.A. en tanto su actividad como empresas de medicina prepaga al adquirir el SANATORIO LAS LOMAS S.A.

Que la teoría del daño a evaluar desde el punto de vista vertical es que el grupo SWISS MEDICAL S.A., que actúa como empresa de medicina prepaga y gestiona sanatorios propios, excluya de la atención médica de sus sanatorios a afiliados de otras coberturas médicas competidoras, aguas abajo.

Que, la firma SWISS MEDICAL S.A. es la segunda empresa de medicina prepaga más importante del país, y la participación de mercado estimada no supera el VEINTE POR CIENTO (20%), aun considerando el escenario restringido a las grandes empresas de medicina prepaga.

Que la firma SWISS MEDICAL S.A. tendrá el CATORCE COMA SEIS POR CIENTO (14,6%) de la participación en el mercado de atención sanatorial, considerando un escenario de máximo nivel de restricción posible.

Que al momento de la notificación de la concentración económica 1938, el SANATORIO LAS LOMAS S.A. atendía más de CINCUENTA (50) coberturas de salud privadas, que representan más de DOSCIENTOS (200) planes distintos.

Que cabe destacar que no es usual que un centro médico de alta complejidad que se encuentre integrado a una empresa de medicina prepaga opera de forma exclusiva con esa cobertura.

Que también es importante evaluar si podría verse deteriorada la calidad de la atención sanatorial brindada a afiliados de empresas de medicina prepaga competidoras, como parte de los efectos del refuerzo de la integración vertical de «Grupo Swiss Medical».

Que una de las vías mediante la cual podría operar el deterioro de calidad sería a través de la variedad de prestaciones que recibe un paciente, la cual depende del plan y los términos y condiciones que la prepaga haya negociado previamente con el sanatorio, y en ese sentido, cabe mencionar que en caso de que se vean afectados las condiciones de los acuerdos negociados de manera previa, las empresas de medicina prepaga tienen numerosos sanatorios a los que puede recurrir para incluirlos en su cartilla, que representan al menos el 85% de la oferta de atención sanatorial.

Que el refuerzo de la integración vertical que obtiene la firma SWISS MEDICAL S.A. tras la adquisición del SANATORIO LAS LOMAS S.A. no generaría preocupaciones desde el punto de vista de la competencia.

Que finalmente, cabe analizar el efecto vertical derivado de la adquisición de la firma MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA por parte de la Familia DE ALL, quienes gestionan el SANATORIO OTAMENDI y para eso, debe prestarse especial importancia a los daños a la competencia originados en el posible cierre anticompetitivo de los mercados.

Que, en este caso, la teoría del daño que debe descartarse consiste en que el SANATORIO OTAMENDI excluya de la atención a pacientes de empresas de medicina prepaga competidoras de la firma MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA, y si bien es menos probable, la posibilidad de que la firma MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA deje de demandar servicios de atención sanatorial a otros sanatorios de alta complejidad.

Que el SANATORIO OTAMENDI es una institución polivalente de alta complejidad que cuenta con una reconocida trayectoria en la atención sanatorial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los fines de dimensionar el tamaño relativo del SANATORIO OTAMENDI cuenta con DOSCIENTAS VEINTE (220) camas de internación, lo que representa el CUATRO COMA DOS POR CIENTO (4.2%) del mercado.

Que, al ser un centro médico de alta reputación en términos de calidad médica, es incluido como prestador en la mayoría de los planes superiores de medicina prepaga.

Que MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA, cuenta con DOSCIENTOS CUARENTA MIL (240.000) afiliados lo que representó el CUATRO COMA DOS POR CIENTO (4.2%) de la participación del mercado de grandes empresas de medicina prepaga.

Que resultan válidas las consideraciones vertidas en el apartado anterior, en el sentido que, si bien es de esperar que la distribución de afiliados atendidos en el SANATORIO OTAMENDI cambie a favor de la firma MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA, dado que no es usual que un centro médico de alta complejidad integrado opere de forma exclusiva con una sola cobertura, y atento al peso que MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA, tiene como empresas de medicina prepaga, no es esperable que tras la operación el sanatorio genere un cierre vertical a competidores.

Que no existirían incentivos a que la firma MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA deje de demandar servicios de atención sanatorial a otros sanatorios de alta complejidad, dado que parte de la fortaleza de una empresa de medicina prepaga consiste en expandir su cobertura territorial y contar con cartillas con numerosos prestadores.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, entendió que no habría elementos para considerar preocupante la adquisición del control sobre la firma MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA por parte de la Familia DE ALL.

Que atento a que las participaciones de mercado, tanto aguas arriba como aguas abajo no superan el TREINTA POR CIENTO (30 %) conforme los Lineamientos Para el Control de Concentraciones Económicas aprobado por Resolución N° 208 de fecha 11 de abril de 2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró que la integración vertical de la firma MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA y SANATORIO OTAMENDI no genera daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo de los mercados.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró que las operaciones bajo análisis no despiertan preocupaciones desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

Que la mencionada Comisión Nacional no advirtió la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por las partes notificantes.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que las operaciones de concentración económica notificadas no infringen el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 26 septiembre de 2025 correspondiente a la “CONC. 1938” y su acumulada la “CONC. 1975”, en el cual aconseja a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: a) dispensar a la firma SWISS MEDICAL S.A.

de suministrar la documental precisada en el apartado II.3 del precitado Dictamen y considerar completos los formularios F0+F1; b) dejar sin efecto el requerimiento de información cursado a las firmas ACCORD SALUD (UPCN) y a la SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA DE BUENOS AIRES; c) autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la firma MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA por parte de PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A., en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N°27.442; y d) autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre el SANATORIO LAS LOMAS S.A. por parte de la firma SWISS MEDICAL S.A., en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

Que, mediante el Decreto N°650 de fecha 10 de septiembre de 2025, se asignó al señor Secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín LAVIGNE (D.N.I. N° 30.448.069), el ejercicio de las competencias atribuidas a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO y a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N.º 27.442, en los Decretos Nros.480 de fecha 23 de mayo de 2018, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y 650/25.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

EN EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dispénsase a la firma SWISS MEDICAL S.A. de suministrar la documental precisada en el apartado II.3 del Dictamen de fecha 26 septiembre de 2025 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, correspondiente a la “CONC. 1938” y su acumulada la “CONC. 1975” y considerar completos los formularios F0+F1.

ARTÍCULO 2º.- Déjase sin efecto el requerimiento de información cursado a las firmas ACCORD SALUD (UPCN) y SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la operación de concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA por parte de la firma PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A., en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 4º.- Autorízase la operación de concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre el SANATORIO LAS LOMAS S.A. por parte de la firma SWISS MEDICAL S.A., en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N°27.442.

ARTÍCULO 5°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a publicar el Dictamen de fecha 26 de septiembre de 2025 correspondiente a la “CONC. 1938” y a su acumulada la “CONC. 1975”, identificado como IF-2025-107426191-APN-CNDC#MEC, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese y archívese.



A LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo expediente EX-2023-119991836- -APN-DR#CNDC, caratulado: "*Swiss Medical S.A. y Participaciones Médicas S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC.1938)*" y su acumulado EX-2024-52636601- -APN-DR#CNDC: "*PARTICIPACIONES MEDICAS S.A. Y SWISS MEDICAL S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC. 1975)*".

I DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. Consideración preliminar

1. Las operaciones que analiza el presente dictamen involucran a dos actores de relevancia en el sector salud argentino. Se trata de una secuencia de transacciones que, inicialmente, resultó en la toma de control conjunto de estos actores sobre una empresa de medicina prepaga con activos sanatoriales significativos y que, posteriormente, derivó en una reorganización que implicó la separación y reparto de los activos de medicina prepaga y centros sanatoriales entre las partes adquirentes.

I.2. Actividad de las partes

I.2.1. La empresa objeto de las operaciones

2. MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA ("MEDICUS"), empresa objeto en ambas operaciones, es una compañía de servicios de medicina prepaga que desarrolla su actividad principal en la provisión de servicios de asistencia médica integral a través de planes de salud prepagos. Adicionalmente, MEDICUS cuenta con cuatro *Centros MEDICUS*, que son centros propios de atención ambulatoria de pacientes, uno de los cuales (Centro MEDICUS Azcuénaga) cuenta además con servicios de internación con capacidad para 60 camas.
3. Previo a las operaciones bajo análisis, la estructura accionaria de MEDICUS estaba conformada por tres grupos de accionistas: SWISS MEDICAL S.A. (34,46%), PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A. (30%) y el «Grupo Pavlovsky» (35,54%). «Grupo Pavlovsky» y PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A. (una sociedad *holding* de la Familia DE ALL) ejercían influencia sustancial sobre MEDICUS y sus subsidiarias previo a la primera operación.
4. MEDICUS es controlante exclusivo de SANATORIO LAS LOMAS S.A. y co-controlante de MET CÓRDOBA S.A. (50% de participación, siendo el restante 50% de titularidad de SANATORIO ALLENDE S.A., entidad que no participa en ninguna de las operaciones bajo análisis).
5. SANATORIO LAS LOMAS S.A. ("SANATORIO LAS LOMAS") es la sociedad que explota el sanatorio homónimo, ubicado en San Isidro, Provincia de Buenos Aires. El establecimiento cuenta con 85 camas de internación y consultorios de atención ambulatoria, prestando servicios sanatoriales de mediana y alta complejidad.
6. MET CÓRDOBA S.A. ("MET CÓRDOBA") es una empresa de servicios de medicina prepaga que opera en la provincia de Córdoba, con aproximadamente 40.000 afiliados. La

sociedad permanece bajo co-control de MEDICUS (50%) y SANATORIO ALLENDE S.A. (50%) tanto antes como después de las operaciones bajo análisis.

7. Luego de implementadas las operaciones bajo análisis, PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A. adquiere el control exclusivo sobre MEDICUS (mantiene el co-control sobre MET CÓRDOBA junto a SANATORIO ALLENDE S.A.), mientras que SWISS MEDICAL S.A. adquiere el control exclusivo sobre SANATORIO LAS LOMAS. De este modo, se produjo la separación entre los activos de medicina prepaga y los activos sanatoriales.

I.2.2. Partes adquirentes

8. SWISS MEDICAL S.A. (“SWISS MEDICAL”) integra el conglomerado empresarial conocido como «Grupo Swiss Medical», uno de los principales actores del sector salud en Argentina. Este grupo desarrolla actividades de manera integrada en medicina prepaga y en la prestación de servicios sanatoriales, contando con una extensa red de centros médicos propios distribuidos en el país.
9. PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A. (“PARTICIPACIONES MÉDICAS”) es una sociedad *holding*, que administra la participación accionaria de la Familia DE ALL en MEDICUS.
10. Las actividades desarrolladas por la Familia DE ALL en Argentina incluyen: (i) prestación de servicios sanatoriales; (ii) importación de equipamiento médico; (iii) inversiones inmobiliarias; y (iv) actividad agropecuaria.

I.3. La adquisición del control conjunto sobre MEDICUS (octubre 2023) (Conc. 1938)

11. La operación perfeccionada el 2 de octubre de 2023 —y notificada el 9 de octubre de 2023— consiste en la adquisición del control conjunto sobre MEDICUS y sus controladas SANATORIO LAS LOMAS y MET CÓRDOBA por parte de PARTICIPACIONES MÉDICAS y SWISS MEDICAL.
12. Previo a la transacción, la estructura accionaria de MEDICUS estaba conformada por tres grupos de accionistas con participaciones accionarias aproximadas de un tercio cada uno: SWISS MEDICAL, PARTICIPACIONES MÉDICAS, y «Grupo Pavlovsky» (35,54%).
13. La Conc. 1938 supuso la salida del «Grupo Pavlovsky» de MEDICUS tras un acuerdo verbal entre SWISS MEDICAL y PARTICIPACIONES MÉDICAS para desvincular personal clave en las decisiones de directorio de MEDICUS. Posteriormente, se celebró un contrato de compraventa de acciones mediante el cual subsidiarias del «Grupo Pavlovsky» vendieron su participación accionaria en MEDICUS a los otros dos grupos accionistas.

I.4. Escisión y adquisición del control exclusivo sobre MEDICUS y SANATORIO LAS LOMAS (mayo 2024) (Conc. 1975)

14. La operación perfeccionada el 14 de mayo de 2024 —y notificada el 21 de mayo de 2024— consiste en una reorganización societaria y de las unidades de negocio de MEDICUS, por la cual: (i) PARTICIPACIONES MÉDICAS adquirió el control exclusivo sobre MEDICUS, la cual mantiene el co-control de su subsidiaria MET CÓRDOBA; y (ii) SWISS MEDICAL adquirió el control exclusivo sobre SANATORIO LAS LOMAS.
15. La Conc. 1975 se instrumentó mediante un *Convenio Marco de Reorganización Societaria*.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

II.1. Encuadramiento legal

16. Las operaciones notificadas constituyen concentraciones económicas en los términos del artículo 7º, incisos c) y d), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, respectivamente.
17. La obligación de efectuar las notificaciones obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442 —monto que, al momento del cierre de la Conc. 1938, equivalía a PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES (AR\$ 16.255.000.000,00) y de la Conc. 1975, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)— y las transacciones no encuadran en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

II.2. Hitos procedimentales principales

18. El 9 de octubre de 2023, SWISS MEDICAL y PARTICIPACIONES MÉDICAS notificaron la Conc. 1938 mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.
19. El 21 de mayo de 2024, SWISS MEDICAL y PARTICIPACIONES MÉDICAS notificaron la Conc. 1975 mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.
20. El 27 de mayo de 2024, esta CNDC, considerando la conexidad entre las transacciones y la identidad de las partes intervinientes, dispuso la acumulación de la Conc. 1975 a la Conc. 1938.
21. En el marco de la instrucción, esta CNDC formuló observaciones a los formularios presentados y requirió información adicional, la cual fue oportunamente proporcionada por las partes notificantes.
22. El 20 de marzo de 2024, esta CNDC formuló requerimiento a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD (SSS), conforme con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. La SSS, respondió mediante informes técnicos de fechas 17 y 18 de abril y 15 de mayo de 2024.
23. Asimismo, se requirió información a terceros entre ellos: ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS (OSDE), GALENO ARGENTINA S.A., ASOCIACIÓN MUTUAL SANCOR, OMINT S.A. DE SERVICIOS, MEDIFE ASOCIACIÓN CIVIL, ACCORD SALUD (UPCN), SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES. A excepción de los dos últimos requerimientos-que se dejan sin efecto en este acto- todos los pedidos restantes fueron oportunamente contestados.
24. En agosto de 2024 se celebraron audiencias testimoniales en la sede de esta CNDC con empleados de las siguientes empresas de medicina prepaga: GALENO ARGENTINA S.A., ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS (OSDE), OMINT S.A. de SERVICIOS y ASOCIACIÓN MUTUAL SANCOR.
25. El 20 de agosto de 2025, las partes notificantes efectuaron una presentación espontánea, y dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0+F1 acompañado.
26. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 20 de agosto de 2025.

II.3. Solicitud de dispensa

27. El 6 de enero de 2025, SWISS MEDICAL solicitó la dispensa de presentar la totalidad de los balances de las empresas afectadas.

28. Considerando que la información ya aportada resulta suficiente para la investigación y elaboración del presente dictamen, corresponde eximir a SWISS MEDICAL de aportar dicha documentación.
29. En consecuencia, se recomienda a la Secretaría de Industria y Comercio dispensar a SWISS MEDICAL de acompañar la documentación indicada y considerar completa la notificación en atención a que, en este caso, la información omitida no resulta imprescindible para el análisis de las operaciones bajo examen.

III EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADAS

III.1. Naturaleza de las operaciones

30. Como se indicó, la Conc. 1938 consiste en la toma del control conjunto sobre MEDICUS y sus controladas SANATORIO LAS LOMAS y MET CÓRDOBA por parte de PARTICIPACIONES MÉDICAS y de SWISS MEDICAL, mientras que la Conc. 1975 consiste en la toma de control exclusivo sobre SANATORIO LAS LOMAS por parte de SWISS MEDICAL, y sobre MEDICUS por parte de PARTICIPACIONES MÉDICAS.
31. Dado que el tiempo transcurrido entre ambas operaciones no fue suficiente para generar efectos económicos significativos en los mercados involucrados, cualquier efecto que pudiera haberse producido se habría disuelto a partir de la implementación de la Conc. 1975.
32. Por ello, a los fines del presente análisis, las empresas afectadas se considerarán en su configuración final, resultante de la segunda operación notificada.
33. A continuación se detallan las actividades de las empresas afectadas en Argentina:

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina.

PARTICIPACIONES MÉDICAS	
SANATORIO OTAMENDI	Prestación de servicios sanatoriales. Consultorios externos de atención ambulatoria
GALICANTO S.A.	Administración y gestión de alquileres de inmuebles
DARIER S.A.	Actividad agropecuaria en campos en Entre Ríos
GRUPODEALL S.A.	Actividad agropecuaria y servicios complementarios
AGROPECUARIA ABADÓN S.A.	Actividad agropecuaria en campo en Entre Ríos
CONMIL S.R.L.	Importación de equipamiento médico
CHENGO S.A.	Servicios inmobiliarios
INMOBILIARIA SANTIAGO S.A.	Servicios inmobiliarios
MANCORETÁ S.A.	Actividad agropecuaria en campo en Entre Ríos

MJJ HNOS. S.A.	Actividad agropecuaria en campos en Entre Ríos
Objeto	
MEDICUS	Asistencia médica y científica
MET CÓRDOBA	Asistencia médica integral y comercialización de seguros médicos

GRUPO SWISS MEDICAL

SWISS MEDICAL	Asistencia médica integral y comercialización de seguros médicos, seguros generales y seguros de vida
ECCO S.A.U.	Prestación de servicios de emergencias médicas
INSTITUTO DE SALTA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.U.	Comercialización de seguros de vida
SMG CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A.U.	Comercialización de seguros generales
SWISS MEDICAL ART S.A.U.	Comercialización de seguros de Riesgos del Trabajo
SMG LIFE CIA. DE SEGUROS DE RETIRO S.A.U.	Comercialización de seguros de retiro
SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.U.	Comercialización de seguros de vida
SMG INMOBILIARIA S.A.U.	Inmobiliaria
SMG SERVICES S.A.	Asistencia médica integral. Tiene como proyecto económico la explotación de una clínica en Nordelta que se encontraba en construcción al momento de la notificación
MANUTO SEGURIDAD S.A.	Seguridad física
SMG TRAVEL S.A.U.	Servicios minoristas de Agencia de Viajes
INTENSA TV S.A.	Servicio de comunicación audiovisual y radiodifusión
AMERICA TV S.A.	Explotación de servicios de radiodifusión
RED CELESTE Y BLANCA S.A.	Radiotransmisión de onda abierta
JUNIN TV S.A.	Explotación de servicios de radiodifusión
SM GROUP CLINICAS MZA S.A. (ETAPA PREOPERATIVA)	Servicios de administración, gerenciamiento y explotación de sistemas privados de medicina prepaga, auditoria y contralor de prestaciones médicas

SMG FIDUCIARIA S.A.U.	Constitución y administración de fideicomisos
FIRBIMATIC INTERNACIONAL S.A.	Lavadero Industrial
LA PALOMA PRODUCCIONES S.A.	Realización y producción integral de programas de teatro, cinematografía, televisión, radio y cualquier otro tipo de manifestación cultural o publicitaria
BELAIR CONSTRUCCIONES S.A.	Alquiler de Inmuebles propios
MANIGAN S.A.	Alquiler de Inmuebles propios
BELSIL PRODUCCIONES S.A.	Actividad inmobiliaria y explotación directa de establecimientos rurales
BEIN S.A.	Alquiler de inmuebles propios
FAJUL S.A.	Negociación de vehículos, naves y bienes inmuebles, urbanos o rurales, arrendamientos, permutas y administración de propiedades.
INSTITUTO GAMMA S.A. ¹	Prestación de servicios sanatoriales
HOSPITAL PRIVADO DE ROSARIO S.A. ²	Prestación de servicios sanatoriales
LAS VERTIENTES S.A. ³	Centro médico de consultas ambulatorias
TERAPIA RADIANTES CUMBRES S.A. ⁴	Tratamientos médicos con radiaciones
INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES ⁵	Centro de salud especializado en atención médica cardiovascular

-
- ¹ Si bien no fue declarada como empresa afectada por la notificante en la presentación del 6 de enero de 2025, dado que el grupo comprador posee en esta empresa una participación accionaria del 38,5% y que la misma desarrolla actividades que podrían relacionarse con las de la empresa objeto, es que se la incluyó en la información económica presentada y, por lo tanto, se incluye en el presente cuadro.
- ² Si bien no fue declarada como empresa afectada por la notificante en la presentación del 6 de enero de 2025, ésta es controlada por INSTITUTO GAMMA S.A., por lo que aplican las mismas consideraciones vertidas en la nota anterior.
- ³ Si bien no fue declarada como empresa afectada por la notificante en la presentación del 6 de enero de 2025, ésta es controlada por INSTITUTO GAMMA S.A., por lo que aplican las mismas consideraciones vertidas en la nota anterior.
- ⁴ Si bien no fue declarada como empresa afectada por la notificante en la presentación del 6 de enero de 2025, ésta es controlada por INSTITUTO GAMMA S.A., por lo que aplican las mismas consideraciones vertidas en la nota anterior.
- ⁵ Se aclara que se encuentra bajo análisis la siguiente operación de concentración económica notificada ante esta CNDC bajo expediente EX-2023-139547159- -APN-DR#CNDC, caratulado “*CIRO HOLDING S.A. E IKANI S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 1948)*”, notificada el 23 de noviembre de 2023. Si bien esta operación no ha sido autorizada a la fecha, se incluye en el cuadro de

CREDITO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U.	REGIONAL	Compañía financiera
Objeto		
SANATORIO LAS LOMAS		Prestación de servicios sanatoriales

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes en el presente expediente.

34. «Grupo Swiss Medical» se encuentra activo en la oferta de servicios de medicina prepaga y en la prestación de servicios sanatoriales a través de clínicas y sanatorios localizados en distintos puntos del país.¹ Por su parte, PARTICIPACIONES MÉDICAS, controlada por miembros de la Familia DE ALL, se dedican, entre otras actividades, a la prestación de servicios sanatoriales mediante el SANATORIO OTAMENDI.
35. En consecuencia, considerando la toma de control del SANATORIO LAS LOMAS por parte de «Grupo Swiss Medical», serán evaluados los efectos horizontales en el mercado de prestación de servicios sanatoriales, así como el refuerzo de la integración vertical derivada de la integración de dichos servicios producto de la operatoria de «Grupo Swiss Medical» como empresa de medicina prepaga (EMP).
36. Por otro lado, en tanto que la Familia DE ALL gestiona el SANATORIO OTAMENDI y adquiere el control de MEDICUS, corresponde evaluar el efecto vertical que trae aparejada esta integración. En relación a los posibles efectos horizontales que pudiera generar esta toma de control en el mercado de atención sanatorial, cabe destacar que los centros médicos operados por MEDICUS están orientados exclusivamente a la atención de afiliados propios², por lo que no existe solapamiento con los servicios ofrecidos por el SANATORIO OTAMENDI a terceros.
37. A continuación, se evaluarán los distintos efectos identificados para las operaciones de concentración que, al momento del análisis, tienen impacto desde el punto de vista de la competencia.

III.2. Descripción del sector

38. En el sistema de salud argentino existen tres subsistemas: la salud pública (que cubre aproximadamente al 36% de la población), la seguridad social, integrada por las obras sociales nacionales, provinciales y la de jubilados (que alcanza al 63,6% de la población); y la medicina prepaga (que cubre al 14% de la población).⁶ De este último grupo, la mayoría (el 60%, es decir, poco más del 8% de la población) derivan aportes vía planes corporativos o desregulación de obras sociales, mientras que el 40% restante adhieren de forma directa (cerca del 5% de la población) sin usar como intermediario a las obras sociales.⁷

empresas afectadas considerando el peor escenario posible, más no puede tomarse ello como prejuizgamiento o adelantamiento de las decisiones que allí se adopten.

⁶ Se aclara que la suma de estos porcentajes no es 100%, ya que hay personas que poseen más de una cobertura de salud y, por ejemplo, existen beneficiarios con más de una obra social, o con obra social y prepaga.

⁷ “Coberturas de salud en Argentina”, Ministerio de Salud de la Nación (2022) ; CADIME y DPT, 2020; “Sistema de salud en Argentina” (2021), IDEAS, disponible en <https://www.institutoideas.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/IDEAS-ODH-Sistema-de-Salud-en-Argentina.pdf>

39. Los actores del mercado habitualmente se refieren a las obras sociales (OS) y EMPs como las “financiadoras”, dado que son éstos los actores que movilizan fondos a los distintos prestadores privados de la salud, *aguas abajo*.
40. En el ámbito privado de la salud, hay tres actores que interactúan entre sí: pacientes, prestadores de servicios médicos y financiadoras de la salud.
41. Los primeros demandan servicios de atención médica a distintos prestadores (sanatorios, laboratorios, profesionales), que son elegidos en función de la necesidad del paciente y del tipo de cobertura médica que tenga. Un paciente será atendido en el centro médico elegido en general sólo si cuenta con un plan de salud de alguna empresa que lo incluya en su cartilla. Es decir, la demanda de los servicios de atención médica por parte de los pacientes está mediada por los financiadores de la salud, quienes ofrecen coberturas más o menos extensas según el plan elegido. Por lo tanto, la elección de un centro de salud o prestador médico se ve influida por el tipo de cobertura y las características de la cartilla que se tenga.
42. El accionar de las OS y EMP es regulado por la SSS, cuyo principal objetivo es fiscalizarlas para garantizar los derechos de los beneficiarios a las prestaciones de salud.

III.3. Definición de los mercados relevantes

III.3.1. Medicina prepaga

43. El servicio de medicina prepaga consiste en la cobertura de atención sanitaria, que incluye una amplia gama de prestaciones médicas, desde consultas y tratamientos hasta internaciones y cirugías. Las EMPs suelen brindar distintos planes orientados a diversos grupos poblacionales, con cartillas especializadas que se ajustan a las necesidades y posibilidades económicas de cada afiliado.
44. Existen también planes de salud consensuados con otras empresas para ofrecer cobertura específica a sus empleados, denominados planes “corporativos”. En algunos casos, el tipo y variedad de prestaciones es similar a la de un plan ofrecido a terceros, y en otros se hace “a medida”.
45. Esta CNDC ya analizó el mercado de medicina prepaga previamente y lo definió como “*aquel en el que se comercializan planes de salud a cambio de pagos voluntarios de particulares o mediante convenios con obras sociales, empresas o asociaciones de personal jerárquico.*”⁸

⁸ “VILLA LARROUDET Y CIA S.A. Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 729)”, Resolución (ex) SC 617/09 del 21 de septiembre de 2009, Dictamen CNDC N° 747 del 4 de septiembre de 2009, Expediente S01:0434426/2008.

“OBRA SOCIAL UNIÓN PERSONAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, DLJMB FUNDING II INC. Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 899)”, Resolución (ex) SC 73/13 del 26 de julio de 2013, Dictamen CNDC N° 997 del 4 de junio de 2013, Expediente S01:0148757/2011.

“GALENO ARGENTINA S.A., JULIO ALFREDO FRAOMENI, MAPFRE ARGENTINA HOLDINGS S.A. Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1054)”, Resolución (ex) SC 176/16 del 15 de julio de 2016, Dictamen CNDC N° 1234 del 18 de marzo de 2016, Expediente S01:0051527/2013.

“GRUPO HOSPITALARIO S.A., CONSOLIDAR SALUD Y CLÍNICA BAZTERRICA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY N° 25.156 (Conc. 459)”, Resolución (ex) SCT 175/2004 del 26 de noviembre de 2004, Dictamen CNDC N° 406 del 18 de noviembre de 2004, Expediente S01:0109409/2004.

“SWISS MEDICAL S.A. S/INFRACCIÓN LEY 25156”, C. 1539, Resolución (ex) SECC 305/2017 del 17 de abril de 2017, Dictamen CNDC N° 25 del 2 de febrero de 2017, Expediente S01:0050993/2015.

46. La prestación de servicios de medicina prepaga se inicia con la captación y afiliación de nuevos miembros. Este proceso comprende campañas de marketing, promociones y la asesoría personalizada para que los potenciales clientes elijan el plan que mejor se ajuste a sus necesidades y posibilidades. Una vez afiliado, el cliente accede a la red de prestadores de la empresa, que incluye clínicas, sanatorios, hospitales, consultorios y centros de diagnóstico.
47. La siguiente etapa es la gestión de la atención médica, que abarca desde la solicitud de turnos y consultas hasta la autorización de estudios y tratamientos. Los afiliados pueden gestionar sus citas a través de los sitios *web* de su EMP, aplicaciones móviles, o centros de atención telefónica. Cuando un afiliado requiere atención médica, éste realiza una consulta con un profesional de la salud perteneciente a la red de prestadores, la cual puede ser presencial o virtual. Si el diagnóstico requiere estudios adicionales o tratamientos especializados, la EMP autoriza estos servicios, asegurando la cobertura según el plan contratado. El proceso también incluye la gestión administrativa y facturación de los servicios prestados, y la evaluación de la calidad de atención.
48. Desde el punto de vista de la oferta, las EMP deben contratar prestadores de salud para satisfacer las necesidades de sus afiliados, o pueden también integrarse verticalmente en la atención directa de ciertos servicios.
49. En efecto, la mayoría de las grandes EMP, como *Swiss Medical*, *Medicus*, *Omint* o *Medijé*, se encuentran integradas verticalmente en la prestación de servicios sanatoriales. Existen también prestadores asistenciales que ganaron prestigio y se integraron hacia adelante ofreciendo planes de salud propios. Algunos de estos son el Hospital Alemán, el Hospital Británico o el Hospital Italiano.
50. Desde el punto de vista de la demanda, mientras las obras sociales captan a sus afiliados (trabajadores en relación de dependencia) a través de los aportes compulsivos, las EMP captan afiliados que no estén en relación de dependencia, o aquellos que sí lo están y eligen un plan superior. Por ende, las EMP compiten por captar clientes según sus preferencias y para tal fin segmentan la oferta en planes.
51. Algunas de las características que diferencian las distintas coberturas de salud son si los planes resultan ser *abiertos* o *cerrados*⁹, el tipo y número de prestadores en cartilla (médicos, centros de diagnóstico y sanatorios para guardia, internación y cirugías), la cobertura geográfica en el país, si ofrecen o no cobertura en el exterior, el número de consultas máximas en ciertas especialidades (psicología, odontología, kinesiología y fonoaudiología), posibilidad de pedir reintegro en algunas especialidades, y la cobertura de tratamientos y/o cirugías odontológicos, oftalmológicos y estéticos.

"*SWISS MEDICAL S.A Y MEDICIEN S.A S/NOTIFICACION ART 8 LEY 25.156*" (CONC 263)", Resolución (ex) SCDDC 92/2001 del 21 de agosto de 2001, Dictamen CNDC N° 278 del 17 de agosto de 2001, Expediente 064-020707/2000.

⁹ Un plan abierto posibilita a los afiliados elegir entre recibir atención médica de prestadores de cartilla o atenderse con prestadores externos, solicitando posteriormente reintegros por el pago del mismo. Por el contrario, los afiliados que tengan planes cerrados sólo pueden acceder a atención médica exclusivamente a través de los profesionales y centros incluidos en la cartilla.

52. De acuerdo a lo declarado en las audiencias testimoniales celebradas con diferentes EMP, y lo relevado en los distintos sitios *web*, pueden identificarse las características de cada plan y determinar cuáles compiten entre sí.¹⁰
53. A continuación se resume la oferta de planes de salud privados ofrecidos al momento del análisis de las presentes operaciones:

Tabla 2 | Planes de salud privados ofrecidos por las principales EMP, año 2024

Tipo de plan	EMP						
	Swiss Medical	OSDE	Galeno	Medicus	Omint	Sancor	Avalian
Gama Alta “Top”	SMG70	510	550	Plan Azul		Plan 6000 exclusive	
	SMG60	450	440	Plan Celeste	Plan Premium	Plan 5000 exclusive	
	SMG50	410	400		Clásico		
	SMG40	310	330				
	SMG30		300				
Gama Media				Family Family flex		S4500	Plan selecta (AS500)
						S4000	
	SMG20	210	220		Global	S3500	
	SMG02		200		Génesis	3000R	
						3000B	
						S3000	
Gama baja	s1	-	-	Integra 2	Comunidad	1500R	AS400
	s2			Integra 2 flex	Midoc	1500B	AS300
				Conecta		S1500	AS200
				Mujer		1000R	AS100

Fuente: elaboración propia en base a información de la SSS, respuesta a requerimientos de información de terceros y distintos sitios web de empresas competidoras.

54. En el caso de las EMP involucradas, SWISS MEDICAL ofrece 9 planes de salud, de los cuales 5 (*SMG 30, SMG 40, SMG 50, SMG 60, SMG 70*) poseen la cartilla *premium*, teniendo en común el acceso a los mismos sanatorios para internación o guardia (52 para la zona de

¹⁰ A modo de ejemplo, el testigo de Galeno declaró que “con respecto a Swiss Medical S.A.: SMG 02 compite con azul 220, el SMG 03 con plata 330 y el SMG 04 con el oro 440. El oro 550 desconozco con cual compite de la competencia. Con respecto a OSDE: OSDE 210 compite con azul 220, OSDE 310 con plata 330, OSDE 410 compite con el oro 440 y OSDE 450 compite con el oro 550. Considero que se compite con esas dos empresas y con esos planes, son a los que mayor relevancia les da Galeno Argentina S.A.”.

- AMBA), pero diferenciándose en los topes máximos de consultas, reintegros, y tratamientos incluidos. Los 4 planes restantes (*S1*, *S2*, *SMG 02*, *SMG 20*) tienen 2 tipos de cartillas distintas (*Global*, cartilla para los planes *S2* y *SMG 20*, con 49 sanatorios para internación, y *Quality*, cartilla para los planes *S1* y *SMG 02*, con 35 sanatorios en cartilla).¹¹
55. Si bien existen diferencias en el número de prestadores, las diferencias más sensibles de los planes más bajos son la existencia de copagos (por ejemplo, el plan *S1* contempla consultas médicas y estudios de diagnóstico y tratamiento con copago) y los requisitos para la solicitud de reintegros.¹²
56. Por su parte, MEDICUS ofrece 5 planes generales (*Azul*, *Celeste*, *Family*, *Integra* y *Conecta*), cada uno con cartillas distintas y modalidades de cobertura específicas. Los planes superiores, *Azul* y *Celeste*, ofrecen 23 sanatorios en cartilla, visita de médico a domicilio, reintegros y numerosos tratamientos, mientras que el Plan *Family* ofrece 15 sanatorios en cartilla, reduce el tope de sesiones permitidas y no incluye médico a domicilio. En el caso de la cartilla del plan *Integra* ofrece 11 sanatorios, pero excluye la cobertura en el exterior, el médico a domicilio, reduce más el tope de sesiones permitidas y cambia los requisitos para solicitar reintegros.
57. Por su parte, MET CÓRDOBA, es una EMP que ofrece cobertura local en la provincia de Córdoba, y ofrece 3 planes: *MA Supra*, *MB Integral*, *MC Classic*. Sólo el primero tiene beneficios sin topes ni copagos.
58. Por lo descripto previamente, algunas de las variables que un afiliado deberá tener en cuenta a la hora de elegir un plan de cobertura médica es la extensión geográfica de la cobertura, el número y tipo de prestadores médicos en cartilla, tope de copagos, reintegros y número máximo de consultas especiales.
59. Al ser consultado por las diferencias entre los planes, el testigo de Galeno declaró: “*Las cartillas son muy inclusivas. La diferencia entre los planes radica en la cantidad de profesionales que incluye la cartilla de cada uno de los planes y los copagos. En los servicios de internación no hay diferencias entre planes*”.
60. También el testigo de OSDE declaró: “*Básicamente tienen todos la misma cartilla, cobertura, en los planes altos hay mayor cantidad de días de acompañante, acceso a habitaciones en suite y cobertura en cirugías estéticas como plus adicional. Los afiliados corporativos puede ser que tengan acceso a algún plan con beneficios adicionales como una mayor cobertura en medicamentos o mayores montos de reintegro. Respecto a los adherentes y superadores no tienen mayores diferencias. Son planes similares con nombres distintos con algún complementario adicional*”.
61. En ese sentido, el tipo, número y reputación de los sanatorios incluidos sería un factor más a considerar dentro del conjunto de características de cada plan. La calidad del servicio médico ofrecido es una variable asociada más generalmente a la atención sanatorial, motivo por el cual se desarrollará en el apartado siguiente.

¹¹ Existen planes denominados *SMG 10* o *SMG 01*, que estuvieron disponibles en el pasado, pero su comercialización fue suspendida, quedando bajo un régimen de run-off, es decir, en la que solo gestionan afiliados hasta ese momento sin incorporar nuevos. Las características de los planes *SMG 01* y *SMG 10* son similares a las de los actuales planes *S1* y *S2* respectivamente. A marzo de 2025, los planes *SMG 10* y *SMG 01* contaban con un total de 4.759 y 2.349 afiliados, respectivamente.

¹² «Grupo Swiss Medical» también ofrece tres planes parciales exclusivos para beneficiarios de obras sociales, dos de ellos con cobertura ambulatoria exclusiva (que incluye consultas médicas, medicamentos, estudios y prácticas de baja y alta complejidad) y otro que incluye emergencias médicas en domicilio y guardia, internación clínica y quirúrgica y medicamentos en internación.

62. Con anterioridad, esta CNDC evaluó el mercado de medicina prepaga y utilizó algunos de estos criterios para clasificar a las EMPs.
63. En la Conc. 263¹³ se consideraron tres segmentos:
- (a) prepagas de más de 70.000 afiliados, que disponen de centros de internación y diagnóstico propios, radio de acción nacional y parcialmente internacional, precios altos a medios, mejores prestadores, y alta participación de contratos corporativos y de planes abiertos.
 - (b) prepagas de entre 20.000 y 70.000, que en general se caracterizan por tener centros de diagnóstico propios, un menor alcance geográfico, precios intermedios, prestadores de alto y mediano nivel y menor prevalencia de contratos corporativos,
 - (c) prepagas y otras instituciones de menos de 20.000 afiliados que en términos generales carecen de centros de internación o diagnóstico propios, tienen un radio de acción local, precios de medios a bajos, nivel medio de prestadores, convenios mayoritariamente individuales y planes de salud principalmente de tipo cerrado.
64. En el antecedente mencionada se evaluaron que los primeros dos grupos no enfrentan una competencia sustancial de las de menor tamaño. Asimismo, detallaron las limitaciones que desde el punto de vista de la oferta enfrentan las pequeñas EMPs en relación a las capacidades para ofrecer planes de salud con las mismas características que las EMPs grandes.
65. En antecedentes posteriores (Conc. 1054, C. 1539)¹⁴, aunque se evalúan los efectos globales, se presenta una clasificación de las EMPs en cuatro grupos estratégicos:
- (a) Prepagas de más de 100.000 afiliados, que disponen de centros de internación y diagnóstico propios, un radio de acción nacional y parcialmente internacional, precios altos a medios, mejores prestadores y alta participación de contratos corporativos y de planes de salud abiertos.¹⁵
 - (b) Prepagas de entre 15.000 y 100.000 afiliados, con centros de diagnóstico propio, un menor alcance geográfico, precios intermedios, prestadores de alto y mediano nivel, y menor prevalencia en el mercado.
 - (c) Prestadores de servicios sanatoriales que se integraron hacía adelante y lanzaron sus propios planes de salud, con cápitas desde 15.000 hasta 100.000. En general no se orientan al mercado corporativo y su área de influencia es local.

¹³ “*SWISS MEDICAL S.A Y MEDICIEN S.A S/NOTIFICACION ART 8 LEY 25.156*” (CONC 263); Resolución (ex) SCDDC 92/2001 del 21 de agosto de 2001, Dictamen CNDC N° 278 del 17 de agosto de 2001, Expediente 064-020707/2000.

¹⁴ “*GALENO ARGENTINA S.A., JULIO ALFREDO FRAOMENI, MAPFRE ARGENTINA HOLDING S.A. y OTROS*” (CONC. 1054), Resolución (ex) SC 176/2016 del 16 de julio de 2016, Dictamen CNDC N° 1234/2016 del 18 de marzo de 2016, Expediente S01:0051527/2013; “*SWISS MEDICAL S.A. S/INFRACCIÓN LEY 25156*”, C. 1539, Resolución (ex) SECC 305/2017 del 17 de abril de 2017, Dictamen CNDC N° 25 del 2 de febrero de 2017, Expediente S01:0050993/2015.

¹⁵ Al momento de la emisión del citado dictamen, las EMPs que conformaban el primer grupo eran OSDE, SWISS MEDICAL, MEDICUS, GALENO, CS SALUD, MEDIFE y OMINT⁹ el grupo 2 FEMEBA, ACA SALUD, SANCOR SALUD, STAFF MÉDICO, CEMIC, UAI SALUD, FEMEDICA, CIMESA, SAMI y CIRME, en el grupo 3 Hospital Alemán, Hospital Italiano, Hospital Británico, Hospital Privado de Córdoba, Hospital Español de Mendoza.

- (d) Prepagas de hasta 15.000 afiliados que no tienen centros médicos propios, radio de alcance local, precios medios a bajos, nivel medio de prestadores, convenio mayormente individuales y planes de salud cerrados
66. De forma adicional, la SSS establece 3 tipificaciones de EMPs¹⁶, basado en: (i) si brindan al menos un plan de cobertura, (ii) si cuentan con más de 50.000 usuarios, (iii) cápita promedio por usuario igual o superior a \$4.000 (o valor actualizado según cuotas).
67. Tanto SWISS MEDICAL como MEDICUS se encuentran registradas bajo la tipología A (EMP que cumplen los 3 requisitos) y MET CÓRDOBA bajo la tipología B (cumple sólo el primero).
68. En relación a las diferencias entre las EMPs, las partes notificantes informaron que en la actualidad las EMPs grandes suelen ofrecer una amplia variedad de planes, que pueden variar entre 5 y 9 opciones distintas, diseñadas para adaptarse a diferentes necesidades y niveles de cobertura, desde opciones básicas hasta planes premium, mientras que las EMPs pequeñas suelen contar con un catálogo más acotado y una estructura menor, por lo que los planes que ofrecen no suelen ser más de 3.
69. Con respecto a los segmentos poblacionales *target*, informaron que el alcance de las EMPs grandes es mayor que las empresas pequeñas debido a su amplia variedad de planes y cobertura geográfica. Pueden llegar a tener convenios con entre 50 y más de 200 sanatorios a nivel nacional, ofreciendo acceso a una amplia red de profesionales en diversas ciudades. En cambio, la cartilla de las EMPs pequeñas suele ser más limitada, pudiendo llegar a tener convenio con hasta 20 instituciones y con una red de profesionales más reducida, concentrada en áreas más puntuales y específicas con un enfoque local.
70. Desde el punto de vista geográfico, las grandes EMPs ofrecen cobertura nacional, con acceso simultáneo a múltiples establecimientos de salud y servicios adicionales localizadas en todo el país. Con esta perspectiva las principales EMPs desarrollan su estrategia comercial, ya que se ubican distribuidas en las grandes ciudades.
71. Los principales oferentes del sector cuentan con sus oficinas centrales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde allí operan la red completa que puede o no ser propia. Cabe destacar que, de modo individual, ninguna cuenta con alcance total en todas las localidades del país, pero gracias a asociaciones logran tener una cobertura extendida.
72. En el caso de las EMPs más pequeñas, como se señaló, suelen ofrecer planes con menor cantidad de prestadores o prestadores locales, o incluso un único prestador, motivo por el cual, dada la naturaleza de su prestación, tienen un enfoque de coberturas locales, regionales o provinciales. Además, la red de profesionales es más reducida, concentrada en áreas más puntuales y específicas.
73. Por ejemplo, SWISS MEDICAL, alcanza una cobertura extendida a nivel nacional mediante contratos de prestación de servicios profesionales celebrados con prestadores de forma directa (profesionales o instituciones) o indirecta a través de colegios de profesionales. Situación similar se observa con la Familia DE ALL, que logra cobertura nacional gracias a convenios específicos con redes de prestadores pre armadas, la contratación en forma directa a prestadores y/o mediante la utilización de redes que tiene armada la empresa asociada.

¹⁶ De acuerdo a lo establecido por la Resolución SSS 1950/21 (RESOL-2021-1950-APN-SSS#MS), en su artículo 1°.

74. Por lo tanto, dado los criterios de clasificación y segmentación utilizadas en el pasado por esta CNDC y consideraciones realizadas por la SSS en sus informes técnicos, resulta pertinente que, a los fines del análisis de las presentes operaciones, sean consideradas las grandes prestadoras de medicina privada con influencia nacional, comprendiendo a aquellas EMPs con centros médicos propios y/o con más de 100.000 afiliados.
75. Esta delimitación considera un escenario restringido, bajo la premisa de que únicamente las EMPs incluidas en este grupo cumplen las condiciones antes detalladas, y ofrecen servicios comparables entre sí en términos de variedad y cobertura de planes. De esta manera, los demandantes de medicina prepaga pueden migrar a otras EMPs si encuentran una oferta más atractiva en términos de costos, cobertura o calidad de servicio, al considerarlas sustitutas al momento del presente análisis. Por lo tanto, debe tenerse en consideración el aspecto dinámico de la delimitación aquí utilizada.
76. En conclusión, a los fines del análisis particular de las operaciones notificadas, y considerando lo manifestado por la SSS en sus informes técnicos, esta CNDC estudiará los efectos en el mercado de medicina prepaga haciendo particular foco en el segmento de empresas con más de 100.000 afiliados.

III.3.2. Prestación de servicios sanatoriales

77. El mercado de prestación de servicios sanatoriales en Argentina incluye la atención sanitaria en una variedad de instituciones, como clínicas, sanatorios y hospitales, que ofrecen servicios médicos y quirúrgicos a la población.
78. El mercado de servicios de centros de salud ya fue desarrollado por esta CNDC¹⁷ como aquel compuesto por las clínicas, sanatorios y hospitales privados con capacidad de internación de pacientes, que cubren toda la gama de prestaciones clínicas (prestadores polivalentes) o el tratamiento de patologías específicas.
79. Asimismo, se detalló que “*se considera clínica, sanatorio y hospital privado con internación al que reúna las siguientes características: propiedad privada, plantel organizado de médicos, instalaciones permanentes (incluyendo camas para internación) y que disponga de un conjunto de servicios cuya organización se centre en el cuidado continuo del paciente internado (enfermería alimentación, etc.)*”.
80. La prestación de servicios sanatoriales en centros de salud privados en Argentina incluye distintas etapas (no necesariamente acumulativas) que van desde la admisión y diagnóstico inicial (por emergencia, derivación médica o consulta programada), el diagnóstico y planificación del tratamiento, la intervención y tratamiento, lo que puede incluir medicación, terapias, procedimientos no invasivos, intervenciones quirúrgicas, cuidados postoperatorios, y finalmente la rehabilitación y seguimiento.

¹⁷ “VILLA LARROUDET Y CIA S.A. Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 729)”, Resolución (ex) SC 617/09 del 21 de septiembre de 2009, Dictamen CNDC N° 747 del 4 de septiembre de 2009, Expediente S01:0434426/2008.

“OBRA SOCIAL UNIÓN PERSONAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, DLJMB FUNDING II INC. Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 899)”, Resolución (ex) SC 73/13 del 26 de julio de 2013, Dictamen CNDC N° 997 del 4 de junio de 2013, Expediente S01:0148757/2011.

“GALENO ARGENTINA S.A., JULIO ALFREDO FRAOMENI, MAPFRE ARGENTINA HOLDINGS S.A. Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1054)”, Resolución (ex) SC 176/16 del 15 de julio de 2016, Dictamen CNDC N° 1234 del 18 de marzo de 2016, Expediente S01:0051527/2013.

81. Considerando la naturaleza de las prestaciones que ofrezca, una institución sanitaria puede ser monovalente y estar dedicada exclusivamente a una única área de la medicina, o puede ser polivalente y ofrecer servicios sanitarios relacionados a una amplia variedad de especialidades.^{18, 19}
82. Otra variable de clasificación de las instituciones sanitarias citada en el antecedente es la que se basa en la complejidad de la atención ofrecida: para que un sanatorio califique como de “alta complejidad” debe contar con una unidad de cuidados intensivos (UCI), quirófanos y centros de procedimientos aptos para todo tipo de cirugía, en particular cirugías complejas, incluida cardiocirugía y neurocirugía (exceptuando trasplantes, dado que no es exigible para alta complejidad), tecnología avanzada para diagnósticos y tratamientos y equipos médicos especializados, diagnóstico e intervencionismo endovascular; diagnóstico endoscópico, y diagnóstico por imágenes que incluya tomografía y resonancia magnética.
83. Una característica diferencial que también puede ser considerada desde el punto de vista de la demanda a la hora de elegir un centro de salud privado es el servicio de hotelería que puede tener un sanatorio.²⁰
84. El servicio de hotelería de una clínica comprende un conjunto de prestaciones destinadas a incrementar el confort de los pacientes y sus acompañantes. Incluye, la calidad y tamaño de sus habitaciones, sus camas y mobiliario (pueden ser individuales o dobles, con baño individual o compartido, decoradas/ambientadas según el tipo de paciente, con o sin sala de estar, con ropa de cama estándar o premium, con o sin servicio de cama para acompañante), servicio de televisión, cable, telefonía e internet con o sin cargo, atención personalizada por parte del personal de hotelería, la limpieza, servicios de restaurant ofrecido durante la estadía (a la carta, o según tratamiento personalizado), obsequios, y hasta juegos terapéuticos, plaza seca y consola de videojuego para pacientes pediátricos, entre otros servicios adicionales.
85. Estas características buscan brindar al paciente una mejor estadía, de forma accesoria y complementaria al tratamiento médico que necesite. De acuerdo a lo afirmado por el testigo de GALENO en audiencia testimonial: *“La hotelería es parte del servicio que brinda un sanatorio, cuanto mejor sean las comodidades que ofrezcan para pacientes y acompañantes van a ser elegidos por sobre otros. Incide, pero no es tan importante como la calidad médica. Lo que primero valora el paciente es la calidad médica, con qué instrumental se hace, los insumos que se utilizan, el estado del sanatorio desde el punto de vista*

¹⁸ Los centros monovalentes permiten una concentración de recursos, experiencia y tecnología en un campo específico de la salud, con un enfoque de la atención para el tratamiento altamente especializada y adaptada a los problemas de esa área concreta, y con una infraestructura diseñada específicamente para soportar la especialidad en cuestión, con equipos y personal dedicados exclusivamente a esa disciplina.

Por el contrario, una institución polivalente está diseñada para abordar una variedad de condiciones médicas en un solo lugar, lo que permite un enfoque de atención y tratamiento a pacientes con múltiples problemas de salud simultáneamente. Estos suelen tener una infraestructura más amplia y diversificada, con equipos y servicios que abarcan múltiples especialidades, lo que puede llevar a una mayor complejidad en la gestión de recursos. Asimismo, aunque desde un centro monovalente los profesionales pueden colaborar con otros especialistas de otras instituciones, un sanatorio polivalente se caracteriza por la interdisciplinariedad, siendo clave que los equipos médicos trabajen en conjunto para abordar una amplia gama de condiciones y necesidades de los pacientes.

¹⁹ Un centro polivalente es visto como un conglomerado de servicios médicos que atrae a pacientes que necesitan asistencia global o que requieren atención de varias especialidades en un solo lugar, mientras que los pacientes que optan por una institución monovalente, en general ya cuentan con un diagnóstico previo, lo que orienta la demanda del paciente a la elección de un centro especializado.

²⁰ Este es un punto desarrollado por la SSS en distintos informes técnicos.

epidemiológico y recién después se considera la hotelería. Tiene que ver pero no es primordial. Es un combo, pero prioritario es que el procedimiento sea exitoso y con el profesional que uno quiere”.

86. En igual sentido, la testigo de OSDE afirmó que el servicio de hotelería *“es una de las variables, pero no es la única. Es relevante, pero para mí la calidad médica es más importante a la hora de elegir del afiliado”*. De igual manera los testigos de Sancor consideraron que la calidad médica —y no la hotelería— es la principal variable que posibilita la segmentación en el mercado de prestación sanatorial.
87. Existe un gran número de centros de salud que buscan esta estrategia de diferenciación. El representante de OMINT, al ser consultado sobre qué clínicas considera que cumplen con altos estándares de calidad hotelera, tanto de las empresas involucradas como de la competencia, dijo: *“OTAMENDI y el resto que no son San Lucas de Neuquén (que no lo conozco) todas tienen altos estándares de hotelería. Del resto de los sanatorios cumplen HOSPITAL BRITÁNICO, HOSPITAL ALEMÁN, IADT, MATER DEI, ANCHORENA, Clínicas del GRUPO GALENO, Clínicas del GRUPO OMINT. Del Gran Buenos Aires Hospital San Juan de Dios, Sanatorio San Lucas de San Isidro, Hospital Austral, Corporación Médica de General San Martín, Sanatorio Juncal. Todo esto entre otras.”*
88. En consecuencia, conforme lo manifestado por las partes y otros competidores, desde el punto de vista de la demanda, la hotelería es una característica más que evalúan los pacientes, pero ésta no se asocia ni determina la calidad del servicio médico prestado ni los insumos médicos utilizados. Estos últimos son los elementos determinantes que orientan la demanda de los pacientes y los que definen la elección de un centro de salud a partir de una cobertura médica dada.
89. De acuerdo a lo informado por PARTICIPACIONES MÉDICAS lo determinante para los pacientes es la reputación y prestigio del centro médico y de los profesionales que lo integran, la disponibilidad de equipamiento médico de avanzada que asocian a la calidad de diagnóstico, tratamiento y recuperación. El servicio de hotelería varía de acuerdo a lo que cada institución decida como política de gestión. En ese sentido, la atención sanatorial es un servicio diferenciado, que es influido por distintas variables entre las que se encuentra el servicio hotelero.
90. Como se señaló previamente, uno de los compradores, «Grupo Swiss Medical», tiene numerosos sanatorios propios: en la ciudad de Buenos Aires, el Sanatorio De Los Arcos, Clínica y Maternidad Suizo Argentina, Clínica Agote, Clínica Zabala; en la ciudad de Neuquén, San Lucas Maternidad, Clínica San Lucas Pediátrico, Clínica San Agustín; en la ciudad de Salta, Sanatorio Altos de Salta; en la ciudad de Rosario, Hospital Privado de Rosario e Instituto Gamma; y, en provincia de Buenos Aires, Clínica Olivos.
91. Recientemente adquirió el ICBA²¹, un centro monovalente especializado en la atención sanitaria cardiovascular de alta complejidad. Además, al momento de la notificación el grupo estaba construyendo el “Centro Swiss Medical Nordelta”, inaugurado a mediados del 2025.
92. Por su parte, los miembros de la Familia DE ALL se dedican a la prestación de servicios sanatoriales a través del SANATORIO OTAMENDI, localizado en CABA.
93. En el caso de MEDICUS cuenta con cuatro *Centros Medicus* que ofrecen atención ambulatoria de pacientes, uno de los cuales cuenta además con servicios de internación con capacidad para 60 camas (Centro Medicus Azcuénaga). En 2023 adquirió la Clínica de Rehabilitación Humana,

²¹ Ver nota al pie N° 15.

que ofrece tratamientos de rehabilitación, conocidas como “*de tercer nivel*”. Los servicios de rehabilitación y recuperación general se focalizan en rehabilitación traumatológica, convalecencia y postoperatorios, accidentes cerebrovasculares y esclerosis múltiple, entre otros. Cabe reiterar que los *Centros Medicus* son de uso exclusivo para afiliados propios.

94. Finalmente, el SANATORIO LAS LOMAS tiene 4 centros, 3 de ellos con camas de internación en la provincia de Buenos Aires (San Isidro, Pilar y Nordelta) y una sede en Caballito donde funcionan consultorios externos.
95. Como se detalló previamente, los demandantes directos de los centros médicos involucrados son las EMPs y obras sociales.
96. De acuerdo a lo informado por las EMPs involucradas, las relaciones comerciales que establecen con los prestadores de centros médicos sanatoriales son de larga duración, estableciendo contratos que son renovados y actualizados periódicamente en cuanto a los servicios alcanzados y costo. En términos generales, las principales características acordadas son los planes atendidos y la cobertura de los mismos, servicios contratados, precio, plazo de pago, y la documentación a suministrar para que se reconozca el servicio brindado.
97. Cabe recordar que muchas de las EMP están integradas verticalmente en la prestación de servicios sanatoriales, lo que tendría ciertos beneficios desde el punto de vista de la calidad de atención y, de acuerdo a lo informado en el marco de la instrucción, podría dar lugar a diversas innovaciones como el acceso a plataformas integradas de consultas en línea, atención coordinada, entre otros.
98. Bajo este modelo comercial de mayor integración, en general la mayor cantidad de pacientes atendidos en cada uno de los centros corresponde a la EMPs que gestiona la institución. Por ejemplo, en el caso de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, Sanatorio Agote, Sanatorio de los Arcos y Zabala, más del 70% de la demanda proviene de afiliados de SWISS MEDICAL, siendo OSDE —que no cuenta con centros propios— el segundo demandante de estos servicios sanatoriales.
99. En el caso del SANATORIO LAS LOMAS, objeto de la operación, al 2023 la demanda estuvo impulsada principalmente por OSDE (35%-40), luego por MEDICUS y SWISS MEDICAL (10%-15%), GALENO (5%-10%), entre otros (0%-5%).
100. Al ser indagado por esta CNDC, «Grupo Swiss Medical» informa que la diferenciación del servicio sanatorial a los afiliados de distintas obras sociales, coberturas y planes se basa exclusivamente en el tipo de servicio que cada obra social o EMPs (financiadores) tiene contratado con cada uno de los centros médicos por cada tipo de prestación y por cada plan de manera individual. Es así como hay financiadores que no tienen contratado ninguna prestación con algún centro médico, y otros que tienen contratados todas las prestaciones médicas que proporciona un centro médico para sus planes “*top*”, algunas prestaciones para sus planes de gama media y no tienen contratadas prestaciones para sus planes más bajos. En las contrataciones de prestaciones, SWISS MEDICAL (en tanto EMPs) no tiene injerencia alguna en la calidad del prestador.
101. Por su parte, PARTICIPACIONES MÉDICAS informa que no existen *prima facie* servicios específicos destinados (exclusiva o prioritariamente) a afiliados con las mejores coberturas y/o planes. En esa línea, dentro de un mismo tipo de servicio, el SANATORIO OTAMENDI no prioriza o brinda atención personalizada según el plan contratado por el afiliado a la prepaga u obra social. Por el contrario, el único criterio en la asignación de prioridad en la atención es el orden de llegada de los pacientes y su condición médica.

102. En consecuencia, es destacable que el tipo de plan no supone ninguna prioridad o restricción con respecto al acceso a un sanatorio u hospital o calidad del servicio médico brindado. Todos los pacientes, independientemente del plan que tengan, reciben la misma atención médica de las prestaciones que tengan cobertura.
103. En conclusión, la diferenciación de los planes determina el tipo de prestación al que se accede —práctica o procedimiento específico— que se le brinda a un paciente en función al servicio que se tiene contratado, no teniendo incidencia alguna respecto a la calidad o rapidez de la misma, ni realizando tratamiento preferente alguno por contar con cobertura de medicina prepaga del mismo grupo.²²
104. Si bien en general ciertos centros médicos se caracterizan por atender planes superiores —dado el estándar de atención sanitaria que cuentan, así como el nivel del equipamiento y de sus instalaciones—, esta asociación no es lineal ni estática. El testigo de OMINT declaró “... algunas no cubren la totalidad de los planes. Por ejemplo, al Hospital Universitario Austral, Sanatorio Mater Dei, LADT, Hospital Alemán, Hospital Italiano, tienen acceso únicamente a esas coberturas los planes medios y altos a nivel precio.” La representante de OSDE informó “Todos los planes tienen acceso a las clínicas excepto ciertas clínicas que están contratadas que acceden a partir del plan 310 para arriba o sus similares corporativos. Por ejemplo el Sanatorio Otamendi y Miroli S.A. y muchos sanatorios del grupo SWISS MEDICAL como Los Arcos, Clínica Suíza Argentina, Clínica Zabala, Instituto Alexander Fleming, la Trinidad de Palermo atienden desde el plan 310 para arriba.”
105. Este conjunto de sanatorios son centros médicos polivalentes de alta complejidad, todos ellos con una buena reputación en el sector de la salud, tanto por el nivel de atención médica como el confort asociado a sus instalaciones.
106. Cabe señalar que si bien la SSS en sus informes técnicos enfocó su análisis al “segmento de servicios de alta complejidad y hotelería premium incluidos en los planes de salud premium”, conforme surge de lo recabado en el marco de la instrucción y en virtud del análisis realizado por esta CNDC, el servicio de hotelería es un servicio accesorio o complementario al tratamiento médico que buscan los pacientes, y si bien es un diferencial, lo determinante a la hora de evaluar el mercado desde el punto de vista de la demanda es el servicio estrictamente médico. Por el contrario, la alta complejidad de la atención médica sí es un factor necesario para delimitar el mercado.
107. A la luz de todo lo expuesto, y considerando los antecedentes previos, a los fines del análisis de las presentes operaciones, esta CNDC considera apropiado evaluar los efectos de las mismas en la prestación de servicios sanatoriales ofrecidos por centros médicos polivalentes de alta complejidad. Al considerar a este universo de instituciones queda cubierta la oferta de los sanatorios incluidos por las coberturas de salud conforme fueran delimitados en el apartado anterior.
108. Desde el punto de vista geográfico, dadas las características del mercado involucrado, el mercado relevante podría definirse como de alcance local evaluando el área de influencia de los centros de salud involucrados.
109. En esa línea, en los antecedentes citados anteriormente, esta CNDC consideró una definición de mercado geográfico para el mercado de servicios sanatoriales a través de centros de salud de alcance local, comprendida, en el caso oportunamente estudiado, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En ese sentido cabe señalar que influye de forma directa la

²² Si el financiador no contrató algún procedimiento o práctica médica que es necesario realizarle al paciente, se le solicita autorización para realizar la misma.

urgencia de la atención médica que se busca resolver, y el área de influencia de las clínicas involucradas en la operación.

110. En este caso, de acuerdo a lo declarado por PARTICIPACIONES MÉDICAS, el SANATORIO OTAMENDI y el SANATORIO LAS LOMAS atienden principalmente a pacientes localizados en la CABA y el AMBA, y en menor medida del interior del país y el exterior.
111. Por su parte, «Grupo Swiss Medical» operaba al momento de la notificación sanatorios localizados en distintas partes del país: 5 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 1 en la zona norte de la provincia de Buenos Aires (Olivos), 2 en la ciudad de Neuquén, 2 en Rosario, y 1 en la ciudad de Salta.
112. Por lo tanto, considerando los efectos de las operaciones de adquisición notificadas, y en consonancia con los antecedentes de la propia CNDC, los servicios de prestación de servicios sanatoriales ofrecidos por centros médicos polivalentes de alta complejidad serán evaluados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

III.4. Efectos económicos de la operación

III.4.1. Adquisición de SANATORIO LAS LOMAS por parte de «Grupo Swiss Medical»

III.4.1.1. Efecto horizontal en el mercado de prestación de servicios sanatoriales

113. Uno de los efectos que tiene la adquisición del SANATORIO LAS LOMAS por parte de «Grupo Swiss Medical» es el solapamiento en la actividad de atención sanatorial. El aumento de la concentración en este mercado se verifica en CABA y GBA, conforme a la delimitación del mercado geográfica propuesta.
114. «Grupo Swiss Medical» gestiona sanatorios polivalentes en distintas partes del país, de los cuales 4 se localizan en CABA y 1 en zona norte del Gran Buenos Aires, mientras que el SANATORIO LAS LOMAS, cuenta con 4 centros, 3 de ellos con camas de internación en la provincia de Buenos Aires (San Isidro, Pilar y Nordelta) y una sede en Caballito donde funcionan consultorios externos.
115. Para este tipo de análisis, la CNDC consideró que el indicador más representativo de la capacidad operativa de los sanatorios —y el que puede ser elaborado con información accesible— es el número de camas de internación.
116. Por lo tanto, el análisis de efectos se funda en la estimación de las participaciones sobre este dato, en base a información de los establecimientos con internación del Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES).²³ De acuerdo a esta fuente, al 2024 existen 10.455 camas en establecimientos con internación del sector privado en CABA, y 26.908 en la provincia de Buenos Aires.
117. Sin embargo, cabe mencionar que la apertura y disponibilidad de la información pública recolectada no permite medir los efectos en el mercado conforme la definición (geográfica y de producto) sugerida por esta CNDC. Por lo tanto, en este caso se procederá a utilizar la

²³ De acuerdo por lo declarado por las partes notificantes, la información sobre el total de camas que surge del REFES tiene sub- informada la cantidad real total de camas, de manera adicional a situaciones transitorias o de corte que afectan a todo el mercado, debido a que podría existir un número muy importante de instituciones que no tengan datos asignados.

estimación ofrecida por las partes notificantes, toda vez que, de no existir problema con esta definición estrecha del mercado, tampoco lo habrá en una más amplia.²⁴

118. A los fines de aportar información coincidente con los criterios de la SSS en sus informes técnicos, las partes notificantes llevaron a cabo un relevamiento del número de camas informado en las páginas *web* de los establecimientos, en el REFES y en consultoras del sector.
119. Bajo este criterio, computaron la existencia de más de 5.000 camas de internación de centros de salud privados polivalentes de alta complejidad en parte de la zona geográfica afectada.²⁵
120. En la Tabla 3 se expone la información aportada:

**Tabla 3 | Participación de mercado en base al número de camas, 2024
(Corredor Norte de CABA y GBA)**

GRUPO	SANATORIO	ZONA	Nº CAMAS	CAMAS (%)
SWISS MEDICAL	SANATORIO DE LOS ARCOS	CABA	214	13.0%
	CLINICA Y MATERNIDAD SUIZO	CABA	210	
	CLÍNICA ZABALA	CABA	130	
	CLINICA PRIVADA OLIVOS	GBA	85	
	SANATORIO AGOTE	CABA	43	
TOTAL SWISS MEDICAL			682	
	SANATORIO LAS LOMAS*	GBA	85	1.6%
TOTAL SWISS MEDICAL + LAS LOMAS			756	14.6%
HOSPITAL ITALIANO	HOSPITAL ITALIANO	CABA	666	12.6%
HOMINIS	SANATORIO GUEMES	CABA	610	11.6%
GALENO	SANATORIO DE LA TRINIDAD SAN ISIDRO	GBA NORTE	266	9.4%
	SANATORIO DE LA TRINIDAD PALERMO	CABA	229	
TOTAL GALENO			495	
ACCOR UP	SANATORIO	CABA	200	7.5%

²⁴ A efectos de ofrecer una estimación de las participaciones de mercado de SWISS MEDICAL de acuerdo con el criterio adoptado de la SSS, las partes notificante aportaron el número de camas de los centros de salud privados, considerando (i) clínicas polivalentes; (ii) nivel de complejidad alto (que cuenten con UTI/UCO); (iii) que cuenten con un servicio de “hotelería premium” (entendido en este caso como la disponibilidad de habitaciones individuales); y (iv) que se encuentren en la zona norte de la CABA y del GBA.

²⁵ Como se detalla en la nota anterior, el análisis se restringió específicamente a la zona norte de CABA y GBA, excluyendo ciertos sanatorios que están localizados en la zona sur de CABA y que, de acuerdo a la delimitación de mercado de producto, podrían ser incluidos.

	ANCHORENA RECOLETA			
	SANATORIO ANCHORENA SAN MARTÍN	GBA NORTE	196	
TOTAL ACCORD			396	
OMINT	CLINICA BAZTERRICA	CABA	160	6.9%
	CLINICA Y MATERNIDAD SANTA ISABEL	CABA	146	
	CLÍNICA DEL SOL	CABA	58	
TOTAL OMINT			364	
HOSPITAL ALEMÁN	HOSPITAL ALEMÁN	CABA	264	5.0%
CEMIC SAAVEDRA	CEMIC SAAVEDRA	CABA	238	4.5%
ASE/MEDIFÉ	SANATORIO FINOCHIETTO	CABA	172	3.3%
AVALIAN	CLINICA ADVENTISTA BELGRANO	CABA	55	1.0%
INDEPENDIENTE	IADT	CABA	250	4.7%
INDEPENDIENTE	HOSPITAL AUSTRAL	GBA	220	4.2%
FAMILIA DE ALL	SANATORIO OTAMENDI*	CABA	220	4.2%
INDEPENDIENTE	MATER DEI	CABA	146	2.8%
INDEPENDIENTE	CORPORACIÓN MÉDICA DE SAN MARTÍN	GBA	130	2.5%
INDEPENDIENTE	CLINICA SAN CAMILO	CABA	120	2.3%
INDEPENDIENTE	SANATORIO SAN LUCAS	GBA	92	1.7%
INDEPENDIENTE	CLINICA SAGRADA FAMILIA	CABA	61	1.2%
TOTAL			5266	100%

Fuente: CNDC en base a Información provista por la parte notificante Swiss Medical (a partir de estimaciones propias, páginas web de los propios centros de salud, el REFES) y lo instruido en el expediente.

(*) Respecto a estos dos sanatorios (Otamendi y Las Lomas) se considera la información aportada por estas empresas.

121. Como se observa, SWISS MEDICAL es el principal grupo proveedor de servicios sanatoriales, dado que lidera el mercado con el 13% de participación. La adquisición del SANATORIO LAS LOMAS, si bien aumenta la concentración, tendría un impacto poco significativo dado que representa el 1.6%.
122. En términos de variación del HHI²⁶, si el aumento que se produce es menor a 150 puntos, y la participación conjunta de las empresas involucradas es menor al 50%, eso se tomará como un

²⁶ El Índice de Herfindahl-Hirschmann (HHI) es una importante herramienta para la medición de la concentración del mercado. Este índice se define como la sumatoria del cuadrado de las participaciones en el

indicador de que la operación de concentración bajo análisis no despierta preocupaciones desde el punto de vista de la defensa de la competencia. En este caso, la variación HHI sería de 41,8 puntos, situación que confirma un escenario poco preocupante desde el punto de vista de la competencia.

123. Por lo tanto, teniendo en cuenta el análisis que surge de considerar un escenario restringido, que evalúa una competencia más estricta que el del propio mercado conforme fuera delimitado, y en consonancia con los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los “*Lineamientos*”)²⁷, la presente operación no genera preocupación en términos de reducción de la competencia.

III.4.1.2. Efecto vertical de la operación

124. Desde el punto de vista vertical, cabe analizar el refuerzo de la integración producto de la operatoria de SWISS MEDICAL en tanto su actividad como EMP al adquirir el SANATORIO LAS LOMAS.
125. La teoría del daño a evaluar desde el punto de vista vertical es que el grupo SWISS MEDICAL, que actúa como EMP y gestiona sanatorios propios, excluya de la atención médica de sus sanatorios a afiliados de otras coberturas médicas competidoras, *aguas abajo*.
126. Por lo tanto, resulta necesario evaluar la participación de la compradora en el mercado de medicina privada, y el incentivo que ésta podría tener para restringir el acceso a la prestación de servicios sanatoriales a EMPs competidoras.
127. A los fines del análisis particular de las operaciones notificadas, al evaluar el mercado de medicina prepaga, se hará foco en el segmento de grandes prestadoras de medicina privada con influencia nacional, con centros médicos propios y/o con más de 100.000 afiliados.
128. A continuación se presenta el listado de las principales EMP que se incluyen en el mercado tal como fuera delimitado, y sus respectivas participaciones, en base al número de afiliados a nivel nacional:

Tabla 4 | Participación de las principales EMPs, según número de beneficiarios, 2023, Nacional.

EMP	Afiliados	Participación Grandes EMP
Osde	2.200.000	38.7%
Swiss Medical	1.066.193	18.8%
Galeno Argentina	750.000	13.2%
Asociación Mutual Sancor	460.000	8.1%
Omint	320.000	5.6%
Medifé	300.000	5.3%
Medicus	240.000	4.2%

mercado, y los valores del HHI pueden oscilar entre 0 (mercado completamente atomizado) y 10.000 (mercado monopolístico).

²⁷ Los *Lineamientos* fueron aprobados por Resolución SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el [sitio web](#) de esta CNDC.

Accord salud (UPCN)	190.000	3.3%
Hospital Italiano	160.000	2.8%
Total grandes EMPs	5.686.193	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a información aportada por la parte notificante, proveniente de Claves Información Competitiva S.A. y CADIME.

129. Como se desprende de la Tabla 4, SWISS MEDICAL es la segunda EMP más importante del país (en términos de afiliados), siendo OSDE el principal oferente de servicios de medicina privada, con el doble de afiliados que SWISS MEDICAL. La participación de mercado estimada para SMG no supera el 20%, aun considerando el escenario restringido a las grandes EMP.
130. Por su parte, cómo se mostró previamente, SWISS MEDICAL tendrá el 14,6% de la participación en el mercado de atención sanatorial, considerando un escenario de máximo nivel de restricción posible.
131. Al momento de la notificación de la Conc. 1938, el SANATORIO LAS LOMAS atendía más de 50 coberturas de salud privadas, que representan más de 200 planes distintos. La distribución porcentual de sus clientes (en base a los afiliados que atendió y sus respectivas coberturas de salud) sigue una lógica bastante similar al tamaño relativo de las EMPs a nivel nacional: en primer lugar reciben afiliados de OSDE (entre un 35%-40% de afiliados), luego de SWISS MEDICAL (10%-15%), MEDICUS (10%-15%) y GALENO (5%-10%), entre muchas otras que representan menos del 5%.
132. Si bien es de esperar que esta distribución cambie a favor de afiliados propios, cabe destacar que no es usual que un centro médico de alta complejidad que se encuentre integrado a una empresa de medicina prepaga opera de forma exclusiva con esa cobertura.
133. Asimismo, cabe recordar que OSDE, que es la principal cobertura médica elegida por la mayoría de los pacientes, no cuenta con centros médicos propios, motivo por el cual requiere necesariamente de acuerdos con terceros para canalizar la atención de todos sus afiliados, que representan cerca del 40% del total del mercado. Por lo tanto, a priori puede concluirse que SWISS MEDICAL no tendría incentivo para excluir a pacientes de EMP de terceros competidores.
134. También es importante evaluar si podría verse deteriorada la calidad de la atención sanatorial brindada a afiliados de EMPs competidoras, como parte de los efectos del refuerzo de la integración vertical de «Grupo Swiss Medical».
135. Una de las vías mediante la cual podría operar el deterioro de calidad sería a través de la variedad de prestaciones que recibe un paciente, la cual depende del plan y los términos y condiciones que la prepaga haya negociado previamente con el sanatorio. En ese sentido, cabe mencionar que en caso de que se vean afectados las condiciones de los acuerdos negociados de manera previa, las EMPs tienen numerosos sanatorios a los que puede recurrir para incluirlos en su cartilla, que representan al menos el 85% de la oferta de atención sanatorial.
136. Por otro lado, el deterioro podría afectar la calidad de atención al paciente. De acuerdo a lo informado por las partes en relación a la posibilidad de exclusión o preferencia a afiliados que se atiendan en sanatorios del mismo grupo, confirmaron que el tipo de plan de medicina prepaga determina el tipo y variedad de prestación que se le brinda a un paciente pero que no tiene incidencia alguna respecto a la calidad o rapidez de la misma, y que no se realiza tratamiento preferente alguno a pacientes con cobertura de medicina prepaga del mismo grupo.

137. El testigo de Galeno en su presentación de fecha 14 de junio de 2024 declaró que *“Los pacientes de todos los planes reciben atención médica de la misma calidad, y todos tienen asegurada la cobertura del PMO, incluyendo alta complejidad, no hay diferencias en las prestaciones. La diferencia con los planes superiores está basada en la cantidad de prestadores que tienen por cartilla los planes más altos. Es decir, a medida que el plan es superior, la cartilla de ese plan tiene una mayor cantidad de profesionales por especialidad y zonas geográficas”*.
138. Por lo expuesto, el refuerzo de la integración vertical que obtiene SWISS MEDICAL tras la adquisición del SANATORIO LAS LOMAS no generaría preocupaciones desde el punto de vista de la competencia.

III.4.2. Adquisición de MEDICUS por parte de Familia DE ALL

139. Finalmente, cabe analizar el efecto vertical derivado de la adquisición de MEDICUS por parte de la Familia DE ALL, quienes gestionan el SANATORIO OTAMENDI. Para eso, debe prestarse especial importancia a los daños a la competencia originados en el posible cierre anticompetitivo de los mercados. En este caso, la teoría del daño que debe descartarse consiste en que el SANATORIO OTAMENDI excluya de la atención a pacientes de EMPs competidoras de MEDICUS, y si bien es menos probable, la posibilidad de que MEDICUS deje de demandar servicios de atención sanatorial a otros sanatorios de alta complejidad.
140. Como se señaló antes, el SANATORIO OTAMENDI es una institución polivalente de alta complejidad que cuenta con una reconocida trayectoria en la atención sanatorial en CABA. A los fines de dimensionar el tamaño relativo del SANATORIO OTAMENDI en el mercado de prestación de servicios sanatoriales, en la Tabla 3 se muestra que el SANATORIO OTAMENDI cuenta con 220 camas de internación, lo que representa el 4.2% del mercado tal como fuera delimitado.
141. Al ser un centro médico de alta reputación en términos de calidad médica, es incluido como prestador en la mayoría de los planes superiores de medicina prepaga. De acuerdo a lo informado en su página *web*, contempla la atención de aproximadamente 30 coberturas de salud. Entre sus principales demandantes, se encuentran OSDE, seguido por MEDICUS.
142. Por su parte, de acuerdo a la Tabla 4, MEDICUS cuenta con 240.000 afiliados lo que representó el 4.2% de la participación del mercado de grandes EMP.
143. A partir de esto, resultan válidas las consideraciones vertidas en el apartado anterior, en el sentido que, si bien es de esperar que la distribución de afiliados atendidos en el SANATORIO OTAMENDI cambie a favor de MEDICUS, dado que no es usual que un centro médico de alta complejidad integrado opere de forma exclusiva con una sola cobertura, y atento al peso que MEDICUS tiene como EMP, no es esperable que tras la operación el sanatorio genere un cierre vertical a competidores.
144. Asimismo, carecería de incentivos para excluir por ejemplo a pacientes de OSDE, que es la principal cobertura médica elegida por la mayoría de los pacientes que al momento de la notificación eligen atenderse en dicho centro de salud.
145. De igual forma, aplican las consideraciones realizadas en el apartado anterior sobre la posibilidad del deterioro de la calidad de la atención sanatorial brindada a afiliados de EMPs competidoras como parte de los efectos verticales.
146. En este sentido, si bien en teoría el SANTAORIO OTAMENDI podría cambiar las condiciones de atención a pacientes de EMPs de terceros, hay consenso en afirmar que la calidad médica de atención no se ve influida por el tipo de cobertura que cuenta el paciente una vez que accede a una prestación determinada.

147. Finalmente, no existirían incentivos a que MEDICUS deje de demandar servicios de atención sanatorial a otros sanatorios de alta complejidad, dado que parte de la fortaleza de una EMP consiste en expandir su cobertura territorial y contar con cartillas con numerosos prestadores.
148. En conclusión, no habría elementos para considerar preocupante la adquisición del control sobre MEDICUS por parte de la Familia DE ALL. Por el contrario, de acuerdo a lo afirmado en el expediente al indagar sobre los efectos derivados de la integración vertical entre servicios de una empresa de medicina prepaga y servicios sanatoriales, destacaron que en términos generales se generan sinergias que mejoran la eficiencia operativa y la calidad del servicio, dado que se eliminarían márgenes de intermediarios y se optimizarían los recursos.
149. En consecuencia, atento a que las participaciones de mercado, tanto *aguas arriba* como *aguas abajo* no superan el 30% conforme los *Lineamientos*, esta CNDC considera que la integración vertical de MEDICUS y SANATORIO OTAMENDI no genera daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo de los mercados.
150. Por todo lo expuesto, esta CNDC considera que las operaciones bajo análisis no despiertan preocupaciones desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.5. Cláusulas de restricciones

151. Esta CNDC no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por las partes notificantes.

IV CONCLUSIONES

152. Por lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones de concentración económica notificadas no infringen el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
153. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
- (a) dispensar a SWISS MEDICAL S.A. de suministrar la documental precisada en el apartado II.3 y considerar completos los formularios F0+F1;
 - (b) dejar sin efecto el requerimiento de información cursado a ACCORD SALUD (UPCN) y a la SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA DE BUENOS AIRES;
 - (c) autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MÉDICA Y CIENTÍFICA por parte de PARTICIPACIONES MÉDICAS S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442; y
 - (d) autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre SANATORIO LAS LOMAS S.A. por parte de SWISS MEDICAL S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
154. Elévese el presente dictamen a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1938 - Dictamen - Autoriza Art.14 a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.